인플루엔자 항바이러스제, 어떤 약이 나에게 맞을까

오셀타미비르·자나미비르·페라미비르·발록사비르 — 4가지 항바이러스제를 한눈에 비교합니다

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

증상 시작 뒤 48시간 — 골든 타임

항바이러스제는 열·근육통이 시작되고 48시간 안에 먹을수록 효과가 큽니다

48시간

이 안에 시작

열·근육통이 시작된 때부터 셉니다

1~2일

앓는 기간 단축

합병증도 줄일 수 있습니다

48시간이 지나도 쓰는 분

65세 이상, 임신부, 만성질환(천식·당뇨·심부전·신부전 등), 면역이 약한 분,
입원할 만큼 심한 분은 48시간이 지나도 약을 권합니다.

왜 그런가요

이런 분들은 폐렴 같은 합병증 위험이 크기 때문입니다.

Tip · 독감이 의심되면 참지 말고 일찍 진료받으세요.

근거 · 미국감염학회(IDSA) 독감 진료지침 2018 · 미국 질병통제예방센터 2024

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

두 가지 계열, 네 가지 약

셋은 같은 계열이고, 발록사비르(조플루자)만 작용 방식이 다릅니다

같은 계열 3종 — 바이러스가 퍼지는 걸 막음

오셀타미비르(타미플루)·자나미비르(리렌자)·페라미비르(페라미플루)는 바이러스가 세포 밖으로 빠져나가는 단계를 막습니다(뉴라미니다제 억제제).

발록사비르 — 불어나는 걸 막음

세포 안에서 바이러스가 복제되는 단계를 막습니다. 다른 계열에 내성이 생긴 바이러스에도 들을 수 있지만, 혼자 쓰면 내성 변이가 비교적 빨리 생긴다는 보고가 있습니다.

실제 차이는 '어떻게 쓰나'

작용 방식보다 먹는 약·흡입·주사, 그리고 1번이냐 5일이냐가 더 큰 차이입니다.

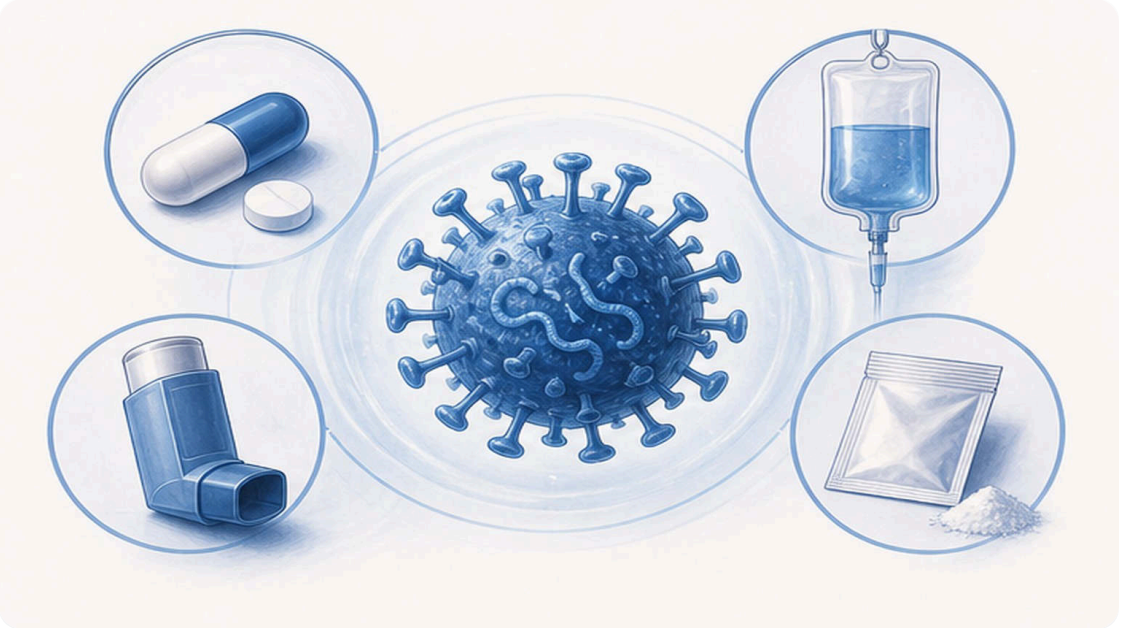


그림 · 독감 약은 먹는 약·흡입제·주사·가루약 등 여러 형태로 나옵니다(설명용 그림).

Tip · 약 이름이 달라도 같은 계열이면 효과는 비슷합니다.

근거 · 미국감염학회(IDSA) 독감 진료지침 2018 · 미국 질병통제예방센터 2024

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

네 가지 항바이러스제 한눈에 비교

쓰는 방법·횟수·건강보험·특징을 정리했습니다

약	쓰는 방법	건강보험	특징
오셀타미비르 (타미플루)	먹는 약 · 하루 2번 × 5일	**급여**	안전성 자료가 가장 많고 임신부·소아 모두 사용 · 구역·구토(소아 15%)
자나미비르 (리렌자)	흡입 · 하루 2번 × 5일	—	위장 부작용 적음 · 천식·만성폐쇄성폐질환은 금기 · 5세 이상
페라미비르 (페라미플루)	정맥 주사 · 1번	비급여 (약 7~9만원)	1번 주사로 끝 · 토하거나 삼키기 어려울 때, 5일 복용이 어려울 때
발록사비르 (조플루자)	먹는 약 · 1번	비급여	열이 가장 빨리 내림(약 24.5시간) · 임신·12세 미만 제한 · 내성 변이 보고

Tip · 어떤 약이 맞는지는 나이·임신·지병·먹을 수 있는지에 따라 함께 정합니다.

근거 · 미국감염학회(IDSA) 독감 진료지침 2018 · Hayden, NEJM 2018(발록사비르) · Kohno 2011(페라미비르)

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

먹는 약 5일과 주사 1번 — 효과는 비슷합니다

기본은 먹는 약 오셀타미비르, 먹기 어려운 상황이면 주사 페라미비르를 고려합니다

오셀타미비르 · 먹는 약

기본 약 — 건강보험 급여, 비용 부담이 가장 적음

- 하루 2번 × 5일(총 10번) — 빠뜨리지 않고 끝까지
- 열 내리는 시간 평균 약 28~38시간
- 증상 좋아지는 시간 약 59~81시간
- 구역·구토 약 10~15%

VS

페라미비르 · 주사

한 번 주사로 끝 — 비급여(약 7~9만원)

- 정맥 주사 1번으로 치료 끝
- 열 내리는 시간 평균 약 37시간
- 증상 좋아지는 시간 약 59~78시간
- 위장 부작용 약 5%대

연구 결과 주사 1번(600mg)은 오셀타미비르 5일과 효과가 뒤지지 않았습니다 — 둘 중 무엇이 더 낫다기보다 상황에 맞춰 고릅니다.

Tip · 주사가 필요한 상황은 다음 장에서 설명합니다.

근거 · Kohno 2011(페라미비르 무작위 시험) · Lee 메타분석 2017

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

주사(페라미비르)를 고려하는 네 가지 상황

먹는 약을 못 먹거나 5일 복용이 어려울 때 1번 정맥 주사가 대안이 됩니다

01

구토가 심할 때

약이 흡수되기 전에 토하면 효과가 없습니다. 주사는 위장을 거치지 않고 약이 모두 몸에 들어갑니다.

가장 분명한 경우

02

아이가 약을 거부할 때

쓴 시럽을 거부하면 주사 1번으로 5일 복용 부담을 덜 수 있습니다.

1번으로 끝

03

5일 복용이 어려울 때

혼자 지내는 어르신 등 규칙적으로 챙겨 먹기 어려운 경우입니다.

1번 방문

04

입으로 먹을 수 없을 때

금식 중이거나 삼키기 어려운 입원 환자는 흡입제도 어려워 주사가 현실적입니다.

입원 환자

Tip · 어떤 약이 맞는지는 진료 때 상황에 맞춰 함께 정합니다.

근거 · 미국감염학회(IDSA) 독감 진료지침 2018 입원 환자 권고

약마다 주요 부작용

대부분 가볍고 지나가지만, 약을 고를 때 상황에 맞춰 봅니다



그림 · 위장·머리·기관지 증상과 콩팥 기능에 따른 약 조절을 나타낸 설명용 그림입니다.

오셀타미비르 — 구역·구토

성인 약 10%, 소아 15~16%. 음식과 함께 먹으면 줄어듭니다.

자나미비르 — 기관지 수축 주의

기침·기관지 수축이 생길 수 있어 천식·만성폐쇄성폐질환은 금기입니다.

페라미비르 — 설사·백혈구 일시 감소

설사 약 8%, 백혈구 일시 감소 약 8%(저절로 회복).

발록사비르 — 대체로 가벼움

위장 증상은 가짜약과 비슷합니다. 임신 중 금기입니다.

Tip · 부작용이 걱정되면 약을 받을 때 먼저 말씀해 주세요.

근거 · 미국 식품의약국 약 설명서 · Kohno 2011 · Hayden, NEJM 2018

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

“이상행동” — 약 탓일까, 독감 탓일까

2025년 큰 연구들은 항바이러스제가 오히려 이상행동을 줄였다고 보고했습니다

50% 감소

이상행동이 줄어듦

미국 소아 69만여 명 — 오셀타미비르 치료군

335만 명

9개 연구 최대 인원

자살·불안·정신증 어느 것도 늘지 않았습니다

원인은 독감 자체일 가능성

일본에서 청소년 사용을 제한한 뒤 다른 약에서도 이상행동이 보고되어, 약이 아니라 독감 자체가 원인으로 보고 2018년 제한을 풀었습니다.

그래도 보호자가 지켜봐 주세요

어떤 약이든 열이 난 뒤 2일 동안은 보호자가 곁에서 지켜보는 것이 필요합니다.

Tip · 아이가 열이 날 때는 혼자 두지 말고 창문 잠금을 확인하세요.

근거 · JAMA Neurology 2025 · JMCP 2025 메타분석 · 일본 후생노동성 2018

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교 바른내과

바로 응급실 — 폐렴·심한 합병증 신호

특히 면역저하·만성질환·임신부는 하나라도 있으면 지체 없이 119

1. **좋아지다가 다시 고열 · 기침 악화** 세균 폐렴
   나아지던 중 다시 고열과 누런 가래 — 독감 4~14일 뒤 흔합니다.

2. **숨참 · 입술·손톱이 파래짐 · 가슴 통증** 산소 부족
   바이러스 폐렴이나 심한 호흡곤란(급성 호흡곤란 증후군) 가능성.

3. **의식 저하 · 경련 · 이상행동** 특히 소아
   열 난 뒤 12~48시간이 위험 — 아이를 혼자 두지 마세요.

4. **탈수 · 소변 줄어듦** 고령·면역저하
   고열·구토로 물이 부족하면 콩팥이 상할 수 있어 수액을 고려합니다.



그림 · 숨이 차거나 의식이 흐려지면 구급차로 바로 병원에 갑니다 (설명용 그림).

Tip · 위험 신호가 있으면 약 효과를 기다리지 말고 바로 119에 연락하세요.

근거 · 미국감염학회(IDSA) 독감 진료지침 2018 중증 독감 · 대한응급의학회 분류 지침 · 식품의약품안전처 안내

약 먹고 토했을 때 · 열이 안 떨어질 때

30분 규칙과 48시간 규칙을 함께 기억하세요

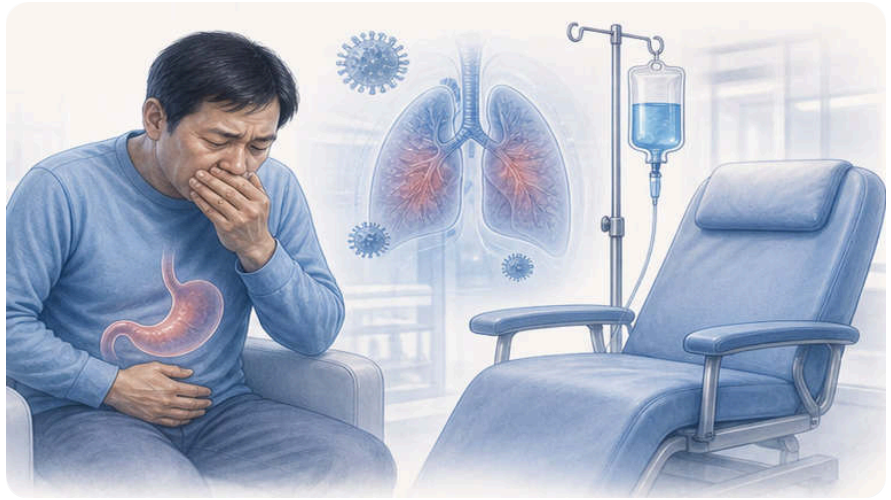


그림 · 계속 토해 약을 못 먹으면 주사 치료로 바꿀 수 있습니다 (설명용 그림).

1 먹고 30분 안에 토함 다시 먹기

아직 흡수 전이라 같은 양을 다시 먹습니다. 음식과 함께 먹으면 덜 메스껍습니다.

2 먹고 30분 뒤에 토함 그대로

이미 흡수돼 다시 먹지 않고, 다음 시간에 평소대로 먹습니다.

3 계속 토함 약 바꾸기

구토약 뒤 다시 → 흡입 자나미비르 → 페라미비르 주사로 바꿉니다.

4 48시간 뒤에도 열 다시 진료

031-893-4560으로 연락 뒤 다시 진료, 엑스레이로 폐렴 확인. 진료시간 밖이면 응급실.

! 주의 꼭

열이 내려도 5일 전에 끊지 마세요. 19세 이하는 아스피린 금지(라이 증후군).

Tip · 약을 일찍 끊으면 바이러스가 덜 없어지고 퍼지거나 내성이 생길 수 있습니다.

근거 · 미국 식품의약국 타미플루 설명서 · 미국감염학회(IDSA) 독감 진료지침 2018 · 식품의약품안전처 환자 안내

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교 바른내과

오늘 꼭 기억할 핵심 여덟 가지

약 고르기부터 복용·지켜보기까지 한눈에

01 증상 시작 48시간 안이 가장 효과적(고위험군은 그 뒤에도)

02 같은 계열 3종은 효과가 비슷 — 발록사비르는 열만 다소 빨리 내림

03 기본은 오셀타미비르(급여) — 비용 부담이 가장 적음

04 토하거나 먹기 어려우면 페라미비르 주사 1번을 고려

05 타미플루는 열이 내려도 5일 끝까지

06 토했을 때 30분 규칙 — 30분 안이면 다시, 뒤면 그대로

07 열 난 뒤 2일간 보호자가 지켜보기(약 종류와 무관)

08 임신부는 오셀타미비르 — 발록사비르는 임신 금기

Tip · 궁금한 점은 약을 받을 때 편하게 물어보세요.

근거 · 미국감염학회(IDSA) 독감 진료지침 2018 · 미국 질병통제예방센터 2024

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

다시 보기 · 문의

QR로 다시 보기 · 검사·집에서 할 일·다시 올 때는 독감·코로나 검사 안내문을 드립니다

광교바른내과

경기 용인 수지구 광교중앙로 298, 4층 · **031-893-4560**
평일 08:30~18:30 · 토요일 08:30~13:30

이 자료의 성격

독감으로 항바이러스제를 처방받는 분과 보호자를 위한 설명자료입니다. 약 선택은 담당 의사와 상의해 정합니다.

참고한 자료

미국감염학회 독감 진료지침 2018 · 미국 질병통제예방센터 2024 · Hayden, NEJM 2018 · Kohno 2011 · JAMA Neurology 2025

SCAN TO REVISIT

집에서 다시 보기

QR을 스캔하면 핸드폰에서
같은 자료를 다시 볼 수 있어요